



6251626622

F-SKIN



ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Warszawa
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 22
tel. +48 22 349 60 12, fax +48 22 349 60 99
e-mail: cs.warszawa@alab.com.pl, www.alab.pl



AM 005

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych**Niechciał Franciszek**

PESEL: 08312605414
Data urodzenia: 26-11-2008
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 1802941
Płeć: mężczyzna

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L.
WARSZAWA-ZAWODZIE
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 14-03-2026 09:25
Data wykonania badania: 14-03-2026

Ident. dokumentu zlecenia: AL92519152
Nr/data w księdze prac. diagn.: 1037 / 14-03-2026

Hematologia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Dokumenty odniesienia
---------------	---------------	---------------------	-----------------------

Materiał: Krew żylna pełna (EDTA), data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24 (Natalia Viazovik), data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:03

Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów

Leukocyty (WBC)	↓	3,01	10⁹/L	4,0 — 10,0	Instrukcja Sysmex 08-2025	A
Rozdział automatyczny leukocytów:						
Neutrocyty (NEU)	↓	1,21	10⁹/L	1,80 — 7,00		
Limfocyty (LYMPH)		1,4	10 ⁹ /L	1,3 — 4,5		
Monocyty (MON)		0,34	10 ⁹ /L	0,10 — 0,90		
Eozynocyty (EOS)		0,05	10 ⁹ /L	< 0,87		
Bazocyty (BASO)		0,01	10 ⁹ /L	< 0,11		
Niedojrzałe granulocyty		0,00	10 ⁹ /L	< 0,03		
Neutrocyty (NEU%)	↓	40,20	%	42,00 — 70,00		
Limfocyty (LYMPH%)	↑	46,5	%	27,0 — 32,0		
Monocyty (MON%)	↑	11,3	%	2,0 — 9,0		
Eozynocyty (EOS%)		1,7	%	0,0 — 5,0		
Bazocyty (BASO%)		0,30	%	0,20 — 1,00		
Niedojrzałe granulocyty %		0,0	%	0,0 — 0,3		
Erytrocyty (RBC)		5,36	10 ¹² /L	4,60 — 5,70		
Hemoglobina (HGB)		15,10	g/dL	13,50 — 17,00		
Hematokryt (HCT)		45,1	%	40,0 — 49,0		
Wskaźniki czerwonych krwinek:						
Średnia objętość erytrocyta (MCV)		84,1	fL	84,0 — 93,0		
Średnia masa HGB w erytrocytach (MCH)		28,2	pg	27,0 — 32,0		
Średnie stężenie HGB w erytrocytach (MCHC)		33,5	g/dL	31,0 — 37,0		
Wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW)		13,3	%	11,5 — 14,5		
Wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW)		40,9	fL	36,0 — 47,0		
Płytki krwi (PLT)		234	10 ⁹ /L	150 — 400		
Wskaźniki płytkowe:						
Płytkokryt (PCT)		0,24	%	0,12 — 0,36		
Wskaźnik anizocytozy płytek krwi (PDW)		11,8	fL	9,8 — 16,1		
Średnia objętość płytki krwi (MPV)		10,2	fL	9,6 — 11,8		
Odsetek płytek dużych		26,4	%	19,2 — 47,0		

metoda cytometrii przepływowej, spektrofotometrii i impedancji, analizator Sysmex XN-10, firma Sysmex

Uwaga! Zmiana wartości referencyjnych od 17.02.2025

Odczyn Biernackiego (C59) 2 mm/h < 15

PB5002_19_15 wyd.1 / 12.10.2015

metoda fotometrycznej analizy kinetyki pomiaru w kapilarze, analizator Test 1, firma BIOMEDICA

Koagulologia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Dokumenty odniesienia
---------------	---------------	---------------------	-----------------------

Materiał: Krew żylna, osocze (cytrynian), data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24, data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:04

D-dimery (G49)	< 215 ng/ml FEU	< 500	Instrukcja Werfen 08-2022
-----------------------	-----------------	-------	---------------------------

metoda immunoturbidymetryczna, analizator ACL TOP 750 LAS, firma Werfen

Głównym zastosowaniem w zakresie diagnostyki pod kątem obecności D-dimerów jest wykluczenie chorób o charakterze zakrzepowym, takich jak zakrzepica żył głębokich czy też zatory płucne. Jeśli wyniki w zakresie oznaczania D-dimerów znajdują się poniżej granicy decyzyjnej, choroby zakrzepowe mogą być wykluczone przy zastosowaniu oceny przedtestowej prawdopodobieństwa klinicznego.

Podany zakres referencyjny nie odnosi się do kobiet w ciąży.



6251626622

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Niechciał Franciszek

PESEL: 08312605414

Data urodzenia: 26-11-2008

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: 1802941

Płeć: mężczyzna

Ident. dokumentu zlecenia: AL92519152

Nr/data w księdze prac. diagn.: 1037 / 14-03-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L.
WARSZAWA-ZAWODZIE

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza

Data i godz. rejestracji zlecenia: 14-03-2026 09:25

Data wykonania badania: 14-03-2026

Biochemia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Dokumenty odniesienia	
Materiał: Krew żylna, surowica , data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24 (Natalia Viazovyyk), data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:09				
Białko C-reaktywne (wysokiej czułości)(I81)	0,06 mg/dl	< 0,50	Instrukcja Abbott 09-2019	
metoda immunoturbidymetryczna, analizator ALINITY C, firma Abbott				
Podwyższone stężenie hs CRP może sugerować większe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Każdorazowo należy wykluczyć infekcje, urazy i inne stany powodujące wzrost CRP.				
Materiał: Krew żylna, surowica , data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24, data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:09				
Magnez w surowicy (M87)	↓ 2,07 mg/dl	2,09 — 2,84	Instrukcja Abbott 05-2023	
metoda spektrofotometryczna, analizator ALINITY C, firma Abbott				
Żelazo w surowicy (O95)	112 µg/dl	31 — 168	Instrukcja Abbott 03-2022	A
metoda spektrofotometryczna, analizator ALINITY C, firma Abbott				
Cholesterol całkowity (I99)	177 mg/dl	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024: Wartość pożądana na czczo i nie na czczo: <190 mg/dl	Instrukcja Abbott 01-2023	A
metoda spektrofotometryczna, analizator ALINITY C, firma Abbott				
Uwaga! Zmiana wartości referencyjnych od 11.02.2026				
Cholesterol HDL w surowicy (K01)	59 mg/dl	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024: Wartości pożadane Na czczo i nie na czczo: Kobiety: > 45 mg/dl Mężczyźni: > 40 mg/dl	Instrukcja Abbott 08-2023	A
metoda spektrofotometryczna, analizator ALINITY C, firma Abbott				
Uwaga! Zmiana wartości referencyjnych od 11.02.2026				
Triglicerydy (O49)	92 mg/dl	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024: Wartości pożadane: Na czczo: <100 mg/dl Nie na czczo: <125 mg/dl	Instrukcja Abbott 05-2023	A
metoda spektrofotometryczna, analizator ALINITY C, firma Abbott				
Uwaga! Zmiana wartości referencyjnych od 11.02.2026				



6251626622

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Niechciał Franciszek

PESEL: 08312605414

Data urodzenia: 26-11-2008

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: 1802941

Płeć: mężczyzna

Ident. dokumentu zlecenia: AL92519152

Nr/data w księdze prac. diagn.: 1037 / 14-03-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L.
WARSZAWA-ZAWODZIE

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza

Data i godz. rejestracji zlecenia: 14-03-2026 09:25

Data wykonania badania: 14-03-2026

Biochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica , data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24, data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:09			
Cholesterol LDL - wyliczany (K03)	100 mg/dl	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024 Wartości pożądane na czczo i nie na czczo: <40 mg/dl - przy ekstremalnym ryzyku sercowo-naczyniowym <55 mg/dl - przy bardzo dużym ryzyku sercowo-naczyniowym <70 mg/dl - przy dużym ryzyku sercowo-naczyniowym <100 mg/dl - przy umiarkowanym ryzyku sercowo-naczyniowym <115 mg/dl - przy małym ryzyku sercowo-naczyniowym	
Nie-HDL	118 mg/dl	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024 Wartości pożądane na czczo i nie na czczo: <70 mg/dl - przy ekstremalnym ryzyku sercowo-naczyniowym <85 mg/dl - przy bardzo dużym ryzyku sercowo-naczyniowym <100 mg/dl - przy dużym ryzyku sercowo-naczyniowym <130 mg/dl - przy umiarkowanym ryzyku sercowo-naczyniowym	

Stężenie cholesterolu LDL w surowicy wyliczane jest wg równania Friedewalda. Stężenie triglicerydów powyżej 400 mg/dl (4,52 mmol/l) uniemożliwia wyliczenie cholesterolu LDL. Wskazane jest wówczas powtórzenie badania lub badanie cholesterolu LDL metoda bezpośrednia.

Parametr wyliczany z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich

Uwaga! Zmiana wartości referencyjnych od 11.02.2026

Materiał: Krew żylna, osocze (fluorek), data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24, data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:10

Glukoza (L43)	76 mg/dl	70-99	Instrukcja Roche 2025-01
		Wartość zalecana przez PTD 2025	

metoda spektrofotometryczna, analizator Cobas c503, firma Roche

Uwaga! Zmiana systemu pomiarowego od dnia 28.10.2025r.

Immunochemia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Dokumenty odniesienia	
Materiał: Krew żylna, surowica , data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24 (Natalia Viazovyk), data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:09				
Witamina B12	471 pg/ml	187 — 883	Instrukcja Abbott 10-2022	A
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott				
Kwas foliowy	3,9 ng/ml	3,1 — 20,5	Instrukcja Abbott 08-2022	
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott				
Materiał: Krew żylna, surowica , data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24, data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:09				
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69)	0,780 µIU/ml	0,470 — 3,410	Instrukcja Abbott 07-2024	A
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott				
Wolna trijodotyronina (FT3) (O55)	3,75 pg/ml	2,25 — 3,85	Instrukcja Abbott 12-2024	A
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott				
Wolna tyroksyna (FT4) (O69)	1,06 ng/dl	0,89 — 1,37	Instrukcja Abbott 02-2018	A
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott				
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18)	< 3,0 U/ml	< 4,11	Instrukcja Abbott 05-2024	A
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott				
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09)	< 3,0 U/ml	< 5,61	Instrukcja Abbott 01-2023	A
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott				
Estradiol (E2)	16,4 pg/ml	< 44,0	Instrukcja Abbott 05-2019	A
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott				



6251626622

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Niechciał Franciszek

PESEL: 08312605414

Data urodzenia: 26-11-2008

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: 1802941

Płeć: mężczyzna

Ident. dokumentu zlecenia: AL92519152

Nr/data w księdze prac. diagn.: 1037 / 14-03-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L.
WARSZAWA-ZAWODZIE

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza

Data i godz. rejestracji zlecenia: 14-03-2026 09:25

Data wykonania badania: 14-03-2026

Immunochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica , data i godz. pobrania: 14-03-2026 09:24, data i godz. przyjęcia: 14-03-2026 14:09			
Witamina 25(OH)D Total (O91)	25,70 ng/ml	< 10 ciężki niedobór 10-20 znaczny niedobór >20-30 stężenie suboptymalne >30-50 stężenie optymalne >50-100 stężenie wysokie >100 stężenie potencjalnie toksyczne	Instrukcja DiaSorin 07-2025
Ocena stanu zapotrzebowania organizmu w witaminę D dla wszystkich grup wiekowych wg Rekomendacji: zasady suplementacji i leczenia witaminą D (2018)			
<i>metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator LIAISON XL, firma DiaSorin</i>			
Ferrytyna (L05)	81,83 ng/ml	21,81 — 274,66	Instrukcja Abbott 07-2023
<i>metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator ALINITY I, firma Abbott</i>			

A

Skład PTARHP: Wolna trijodotyronina (FT3), Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (antytyreoglobulinowe ATG), Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Wolna tyroksyna (FT4), Tyreotropina trzeciej generacji (TSH)

Skład PKTKO20: Glukoza, Morfologia krwi, Cholesterol całkowity, HDL cholesterol, Cholesterol LDL - wyliczany (K03), Triglicerydy, Magnez, Żelazo, Ferr

Wyniki w późniejszym terminie

Homocysteina met. HPLC Czas oczekiwania na wynik do 6 dni roboczych

A – badane cechy i metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; PB - procedura badawcza

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbki, której rodzaj, data i godzina pobrania, data i godzina przyjęcia do badań są identyfikowane w niniejszym sprawozdaniu.

Identyfikacja pacjenta odbywa się na podstawie pierwszych 9 cyfr kodu kreskowego (licząc od lewej). 10 cyfra jest cyfrą przeznaczoną dla laboratorium. Więcej informacji na stronie: <https://sklep.alablaboratoria.pl/922-przygotowanie-do-badania>.

Wykonali

a - Jabłońska Katarzyna
b - Kapcia Katarzyna

Zatwierdzili

1 - mgr Katarzyna Jabłońska
2 - mgr Katarzyna Kapcia

Niniejszy wydruk jest informacją o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Autoryzował: diagnosta laboratoryjny Kapcia Katarzyna nr PWZDL 15412